Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9º Andar - Sala 905 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Balcão Virtual: (51) 99991-4927 - Email: frpoacent3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001932-02.2025.8.21.0001/RS

AUTOR: MARIA CECILIA FLORES

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA movida por MARIA CECILIA FLORES em desfavor da UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (Evento 1). Informa a parte autora que possui o diagnóstico de Transtorno Depressivo Grave resistente ao tratamento (CID-10: F32.2). Trata-se de um caso muito grave e resistente a múltiplas abordagens antidepressivas convencionais, incluindo três classes de antidepressivos (paroxetina, bupropiona, vortioxetina, lamotrigina, trazodona) atingindo doses máximas toleráveis sem resposta adequada. Na atualidade encontra-se em uso de Venlafaxina 75mg/dia, 20 mg/dia e Lamotrigina 200mg. Diante da gravidade do caso, para atingir a remissão dos sintomas, além das estratégias com a associação de outros antidepressivos, antipsicóticos, medicações de outras classes e psicoterapia, deve-se associar também o tratamento com Cloridrato de Escetamina Intranasal para atingir a remissão sintomática e evitar possíveis internações hospitalares. Em 01/10/2024 a autora iniciou tratamento coadjuvante com Cloridrato de Escetamina Intranasal (SPRAVATO®) de forma particular, já que o plano de saúde negou o fornecimento, no Programa de Psiquiatria Intervencionista do Hospital São Lucas da PUCRS, realizou 8 aplicações, com com boa resposta, havendo indicação de continuar a fase de manutenção até completar pelo menos 6 meses de tratamento. Contudo, devido ao alto custo do tratamento, a autora não teve mais como custear de forma particular. Ponderando a gravidade do quadro psiquiátrico (múltiplos tratamentos, episódios severos de depressão e risco à vida por ideação suicida) e a solicitação da médica psiquiatra que acompanha a autora, a Drª. Sayra Catalina Coral Castro (CRM-RS: 40499), solicita a MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO com SPRAVATO® em ambiente ambulatorial (Hospital Dia) ou clínica da infusão, objetivando a remissão dos sintomas e evitando novas recaídas, a fim de resguardar não só a vida da autora, mas, também, a sua dignidade. No mérito, pediu a confirmação da liminar. Acostou documentos.

Deferidas a antecipação de tutela e a gratuidade judiciária (Evento 4).

Citada, a parte ré apresentou contestação (Evento 14). Impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou a ausência de cobertura contratual e legal. O rol da ANS prevê a cobertura da medicação *sub judice* somente para o tratamento antidepressivo, restrito ao uso em ambiente hospitalar, de forma supervisionada, se cumprida todas as diretrizes já expostas, não sendo o caso do autor. Salientou a ausência de urgência ou emergência no caso da autora e ausência de evidência científica. Pediu o acolhimento da preliminar e o julgamento de improcedência. Acostou documentos.

Houve réplica (Evento 18).

Rejeitada a impugnação e instadas as partes a dizer sobre o interesse na dilação probatória (Evento 21).

A parte ré acostou notas técnicas (Evento 31), do que foi oportunizada vista à parte autora (Evento 32).

Vieram os autos conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Ausentes preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre a autora, na qualidade de beneficiária de plano de saúde, e a ré, como operadora, é inequivocamente uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A matéria é, inclusive, objeto da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

A incidência do CDC ao caso concreto resulta na aplicação de seus princípios norteadores, como a proteção da vida, saúde e segurança do consumidor, a boa-fé objetiva, a transparência, o dever de informação e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

O cerne da controvérsia, em sua origem, residia na obrigação da operadora de saúde de custear o tratamento da autora com o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato®) para a patologia que a acomete (Transtorno Depressivo Grave resistente ao tratamento (CID-10: F32.2). A doença da autora possui cobertura contratual, tratando-se de patologia listada na Classificação Internacional de Doenças (CID). A recusa inicial da operadora, embora não tenha sido o foco principal do litígio subsequente, revela uma prática que o Poder Judiciário tem reiteradamente rechaçado.

A definição do tratamento mais adequado para a patologia do paciente é uma prerrogativa exclusiva do médico que o assiste, não cabendo à operadora de saúde imiscuir-se na terapêutica indicada. Se a doença tem cobertura contratual, os meios necessários para o seu tratamento, incluindo medicamentos, procedimentos e materiais, devem ser igualmente cobertos. A operadora pode estabelecer quais doenças estão por ela cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura de cada uma delas. A recusa em fornecer um medicamento prescrito por profissional habilitado, sob o argumento de não constar no rol da ANS ou por ser de alto custo, configura prática abusiva, que coloca em risco a saúde e a vida do beneficiário. Portanto, a pretensão original da autora para o custeio do tratamento é, em sua essência, legítima e amparada pelo ordenamento jurídico.

No mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). USO AMBULATORIAL. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. DEVER DE COBERTURA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINANDO A COBERTURA PELA DEMANDADA DO MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DO TRATAMENTO POSTULADO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL, NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR3. EMBORA AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE ESTEJAM DISPENSADAS DE FORNECER MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, EXCETO ANTINEOPLÁSICOS, NO CASO CONCRETO, É INCONTROVERSO QUE O MEDICAMENTO SOLICITADO É DE USO AMBULATORIAL. 4. O MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR DE QUE TRATA O ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 É AQUELE PRESCRITO PELO MÉDICO, ADQUIRIDO DIRETAMENTE NAS FARMÁCIAS E AUTOADMINISTRADO PELO PACIENTE, DIFERENTE DO CASO DOS AUTOS ONDE O MEDICAMENTO PRESCRITO SERÁ ADMINISTRADO EM AMBULATÓRIO, COM SUPERVISÃO MÉDICA. 5. O ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS É TAXATIVO, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NA LEI Nº 14.454/2022, COMO EFICÁCIA COMPROVADA POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS OU RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃOS TÉCNICOS RECONHECIDOS. 6. EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO SPRAVATO PARA PACIENTES COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, QUE JÁ TENHAM TENTADO DIVERSOS OUTROS TRATAMENTOS SEM SUCESSO. 7. CONFIGURADA HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO, SENDO DEVIDA A COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. IV. DISPOSITIVO8. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50058092520238211001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-02-2025)

Recente legislação alterou a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

A Lei Federal 14.454, de 21.09.2022, em seu artigo 10, § 13, refere que:

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Os precedentes jurisprudenciais também tem sido no sentido de acolher a obrigatoriedade da cobertura do tratamento buscado pela parte autora. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. USO AMBULATORIAL. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina), prescrito para tratamento ambulatorial de transtorno depressivo grave, embora não incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A decisão de origem fundamentou-se no direito à saúde, consagrado constitucionalmente, e na excepcionalidade do caso clínico, com riscos à vida da paciente. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o plano de saúde é obrigado a custear medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não conste no rol da ANS. III. Razões de decidir O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe a proteção da dignidade humana e a garantia do acesso a tratamentos necessários para a preservação da vida. A jurisprudência do STJ e a legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998 e Lei nº 14.454/2022) reconhecem o rol da ANS como referência mínima, admitindo cobertura de procedimentos fora desse rol em hipóteses excepcionais, como a ausência de substituto terapêutico eficaz e prescrição médica justificada. O medicamento Spravato®, sendo de uso

ambulatorial e essencial ao tratamento da autora, caracteriza-se como obrigação de cobertura pelo plano, uma vez que atende às exigências de excepcionalidade e eficácia. IV. Dispositivo Apelo desprovido. Unânime. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929-SP; AgInt no AREsp 1198799/SP.(Apelação Cível, Nº 51066481720248210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-12-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE ESCETAMINA SPRAY NASAL (SPRAVATO). ADMINISTRAÇÃO DO FÁRMACO EM AMBIENTE HOSPITALAR. LAUDO MÉDICO QUE APONTA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51372573520248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 31-07-2024)

Ainda, em consulta ao sistema E-NATJUS -ferramenta de apoio ao Judiciário lançada pelo CNJ e o Ministério da Saúde - verifico notas técnicas em favor autora, que dão conta da possível eficácia do medicamento para casos como o da demandante. Vejamos:

***Nota** Técnica 31426905*[1]

*Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: SPRAVATO® ou **ESCETAMINA** é um antidepressivo com um novo mecanismo de ação, que atua como um modulador do receptor de glutamato. Os receptores de glutamato incluem os receptores ionotrópicos (receptores AMPA, Kainato e N-metil-D-aspartato), que controlam diretamente os canais iônicos, e os receptores metabotrópicos que atuam através do sistema de segundos mensageiros. Em março de 2019, a **escetamina intranasal**, coiniciada com um antidepressivo convencional, foi aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para adultos com TRD (Transtorno depressivo resistente). A Agência Europeia de Medicamentos concedeu aprovação regulatória para a **escetamina intranasal** para TRD em dezembro de 2019, e aprovações adicionais são esperadas em outras partes do mundo. Em agosto de 2020, a FDA atualizou a aprovação da **escetamina intranasal** para incluir adultos com depressão grave e ideação e comportamento suicida. Estudos controlados randomizados de curto prazo replicados estabeleceram inequivocamente a eficácia rápida e significativa de ambas as formulações e vias de administração em adultos com DRT. É indicado para Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina). SPRAVATO® é indicado, em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda. Não foi demonstrada efetividade de SPRAVATO® na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida. Mesmo que o paciente apresente melhoras com as doses iniciais de SPRAVATO, o uso de SPRAVATO não dispensa a necessidade de hospitalização, caso clinicamente justificada. A cetamina e a **escetamina** representam vias de tratamento farmacologicamente novas para adultos com depressão resistente ao tratamento. No entanto, permanecem preocupações sobre a segurança e tolerabilidade da cetamina e **escetamina** em transtornos de humor. Além disso, há incerteza sobre a posição apropriada desses agentes em algoritmos de tratamento, sua eficácia comparativa e o ambiente, infraestrutura e pessoal apropriados necessários para sua implementação competente e segura.*

***Nota** Técnica 291519*[2]

*Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A **Escetamina** é um novo antidepressivo que atua como um modulador do receptor de glutamato. Pela Anvisa, o SPRAVATO® é indicado para: - Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina). - Em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda. O medicamento, deve ser administrado exclusivamente em um hospital ou uma clínica especializada e na presença de um profissional da saúde. Isso se deve ao risco de sérios efeitos adversos resultantes da sedação e dissociação, além do potencial de abuso e uso indevido da droga. O spray deve ser administrado em conjunto com outro antidepressivo oral. As reações adversas mais comumente observadas nos pacientes tratados com **Cloridrato** de **Escetamina** foram dissociação, tontura, náusea, sedação, dor de cabeça, vertigem, disgeusia, hipoestesia, aumento da pressão arterial, ansiedade e vômito. Em cerca de 20% dos pacientes, mas sintomas com melhora rápida. Há diversas metanálises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados que sustentam seu uso para o quadro de depressão refratária os termos descritos acima. Ainda será preciso mais evidência para o uso da medicação tornar-se padronizado. Entretanto, com os trabalhos disponíveis, é razoável tentar seu uso em pacientes que tenham doença muito grave e resistente a outras modalidades de tratamento.*

***Nota** Técnica 103074*[3]

*Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A **Escetamina** é um novo antidepressivo que atua como um modulador do receptor de glutamato. Pela Anvisa, o SPRAVATO® é indicado para: - Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina). - Em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda. Não foi demonstrada efetividade de SPRAVATO® na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida. O medicamento, deve ser administrado exclusivamente em um hospital ou uma clínica especializada e na presença de um profissional da saúde. Isso se deve ao risco de sérios efeitos adversos resultantes da sedação e dissociação, além do potencial de abuso e uso indevido da droga. O spray deve ser administrado em conjunto com outro antidepressivo oral. As reações adversas mais comumente observadas nos pacientes tratados com **Cloridrato** de **Escetamina** foram dissociação, tontura, náusea, sedação, dor de cabeça, vertigem, disgeusia, hipoestesia, aumento da pressão arterial, ansiedade e vômito. Em cerca de 20% dos pacientes, mas sintomas com melhora rápida. Há diversas metanálises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados que sustentam seu uso para o quadro de depressão refratária os termos descritos acima. Ainda será preciso mais evidência para o uso da medicação tornar-se padronizado. Entretanto, com os trabalhos disponíveis, é razoável tentar seu uso em pacientes que tenham doença muito grave e resistente a outras modalidades de tratamento.*

Dessarte, a procedência do pedido é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **MARIA CECILIA FLORES** em face de **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, para: **a) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA** concedida e modificada nos autos (evento 4, DOC1), para **CONDENAR** a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear, de forma integral e contínua, a manutenção do tratamento com Cloridrato de Escetamina Intranasal SPRAVATO® em ambiente ambulatorial (Hospital Dia) ou clínica da infusão, conforme prescrição médica (evento 1, DOC8), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 20 (vinte) dias.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor da causa, considerando o tempo de tramitação da demanda, matéria debatida e julgamento antecipado (art. 85, §2°, do CPC), bem como o tema 1.076 do STJ.

Em caso de interposição de apelação, abra-se prazo à adversa para contrarrazões, e, apresentadas ou decorrido o prazo, remetam-se ao e. TJ/RS, sem necessidade de conclusão.

Transitada em julgado e nada requerido, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MALTEZ KACHNY, Juiz de Direito**, em 30/09/2025, às 06:25:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091981378v6** e o código CRC **e58dbaf0**.

---

1. Disponível em <https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:314269:1749158719:2834a970bb75b393bc2dc546d157e295770357cf51cb7612ab897994eaffb6da> Acesso em 29/09/2025. ↩ ↩
2. Disponível em <https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:291519:1749158719:6577be25c5a27da2fbb06c464a42f7a6cae763813f2df6e7ac26148470b6f82f> Acesso 29/09/2025. ↩
3. Disponível em <https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:103074:1749159059:1b0cdd40ead60fcaaa6d262993a6105d6af27315ce21d9355fd6a0c6a776d28a> Acesso em 29/09/2025. ↩